



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PENGORGANISASIAN GIZI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 337.1/I-PDM/DIR/VI/2026

Tentang
Pedoman Pengorganisasian Gizi

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Gizi



(Ericha Risdawati, AMd.Gz)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur RS Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi RS Prima Husada Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi RS Prima Husada Tahun 2026 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2026 meliputi gambaran umum Rumah Sakit Prima Husada hingga struktur organisasi Instalasi Gizi Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi RS Prima Husada Tahun 2026 ini, mutu pelayanan dan keselamatan petugas rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 06 Juni 2026
Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGORGANISASIAN GIZI

Pengarah & Editor : Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHt., CI., CHAE., CHQP

Penyusun:

1. Sherly Rosita, S.Kep., Ns
2. Ericha Risdawati, AMd.Gz
3. Chandrawati Mustikasari, S.Tr.Gz
4. Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz
5. Nafisah Ulfa Hasanah, S.Gz
6. Najiyatul Fithriyyah., S.Tr.Gz
7. Nurdyna Zahro Latifa, Amd. Gz

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DATAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	1
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT	3
2.1 Deskripsi RS Prima Husada Malang	3
2.2 Sejarah Institusi RS Prima Husada Malang	4
BAB III VISI, MISI, NILAI BUDAYA MOTTO RS	5
3.1 Visi	5
3.2 Misi	5
3.3 Tujuan	5
3.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama	5
3.5 Motto	5
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA	6
4.1 Bagan Organisasi	6
4.2 Keterangan/ Pengertian	8
BAB V URAIAN JABATAN	9
5.1 Uraian Jabatan	9
5.2 Tugas dan Klinis	10
BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA	14
BAB VII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL	18
7.1 Seleksi Calon Karyawan	18
7.2 Pengembangan SDM	21
7.3 Pola Ketenagaan dan Kualifikasi SDM Instalasi Gizi	22
BAB VIII PROGRAM ORIENTASI	23
8.1 Kegiatan Orientasi Umum	23
8.2 Kegiatan Orientasi Instalasi Gizi	24
BAB IX PERTEMUAN RAPAT	
9.1 Pengertian	25
9.2 Tujuan	25
9.3 Kegiatan Rapat	25
9.4 Jenis Rapat Instalasi Gizi	25
BAB X PELAPORAN	
10.1 Pengertian	26
10.2 Jenis Laporan	26
BAB XI PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

TABEL 1 POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL	18
TABEL 2 PERHITUNGAN POLA KETENAGAAN GIZI.....	19
TABEL 3 PERHITUNGAN POLA KETENAGAAN PETUGAS DAPUR.....	19
TABEL 4 PENGATURAN JAGA.....	20
TABEL 5 POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI SDM.....	21
TABEL 6 KEGIATAN ORIENTASI.....	23

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 337.1/I-PDM/DIR/VI/2026**

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN GIZI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin pelaksanaan pelayanan gizi yang optimal di rumah sakit diperlukan adanya standar kebutuhan tenaga gizi secara lebih rinci yang memuat jenis dan jumlah tenaga gizi

b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 773.4/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perhitungan Pola Ketenagaan Berdasarkan Analisis Beban Kerja;

5. Kepdrijen Nomor HK 0107/MENKES/1596/2024 tentang Instrumen Survey Akreditasi Rumah Sakit.

6. Kepdrijen Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survey Akreditasi Rumah Sakit

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi;

8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPM-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN GIZI**

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Instalasi Gizi di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 397.1/I-PDM/IGZ/V/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 6 Juni 2026
Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M.Kes

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI GIZI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan yang paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) rehabilitatif dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik secara perorangan maupun kelompok secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pelayanan gizi rumah sakit (PGRS) merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan paripurna rumah sakit dengan beberapa kegiatan, antara lain asuhan gizi pasien rawat jalan, asuhan gizi pasien rawat inap, penyelenggaraan makanan, serta penelitian dan pengembangan gizi (Departemen Kesehatan RI, 2006). Pelayanan gizi rumah sakit berperan dalam mempercepat penyembuhan pasien dan menjaga agar kondisi tubuh tetap sehat. Dengan gizi yang baik, daya tahan tubuh akan meningkat sehingga dapat mempercepat penyembuhan penyakit dan menghindari komplikasi penyakit lainnya serta dapat membantu mencegah kambuhnya penyakit

Pelayanan Gizi Rumah sakit merupakan suatu penyelenggaraan makanan kepada pasien yang diawali dari perencanaan menu sampai pendistribusian dalam rangka pencapaian status gizi yang optimal melalui pemberian diet yang tepat. Dalam hal ini termasuk juga pencatatan dan pelaporan. Instalasi gizi merupakan suatu unit di rumah sakit yang memiliki tim kerja dengan kemampuan khusus untuk memberikan pelayanan gizi yang bermutu kepada pasien sehingga mempercepat proses penyembuhan pasien dan memperpendek masa rawatnya.

Faktor kebersihan penjamah atau petugas makanan dalam istilah populernya disebut higiene perorangan merupakan prosedur menjaga kebersihan dalam pengelolaan makanan yang aman dan sehat (Depkes, 2001). Prosedur menjaga kebersihan merupakan perilaku bersih untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditangani. Prosedur yang penting bagi pekerja pengolah makanan adalah pencucian tangan, kebersihan dan kesehatan diri. Di Amerika Serikat 25% dari semua penyebaran penyakit melalui makanan, disebabkan pengolahan makanan yang terinfeksi dan higiene perorangan yang buruk (Purnawijayanti, 2001).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari pedoman pengorganisasian instalasi gizi ini adalah sebagai acuan pola pengorganisasian di Rumah Sakit Prima Husada.

1.2.2 Tujuan

- a. Sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah

Sakit Prima Husada.

- b. Memudahkan bagi tenaga gizi untuk membantu terciptanya kelancaran pelayanan makanan kepada pasien.
- c. Setiap tenaga gizi dapat bekerja berdasarkan Visi, Misi, Falsafah, dan tujuan Instalasi Gizi Rumah Sakit Prima Husada.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT

2.1 DESKRIPSI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan No. 3 - 7 Mondoroko, Kec. Singosari, Kab. Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax : 0341 – 441874, email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com , website : www.rs-primahusada.com.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Kepala Bidang yaitu Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis, dan Kepala Bidang Umum dan Operasional.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 SEJARAH INSTITUSI RS PRIMA HUSADA

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kami pun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada.

Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan :

Tahun 1990 – 2005	:	Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	:	Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	:	Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	:	Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	:	Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	:	Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	:	Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	:	Akreditasi Paripurna
Desember 2016	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	:	Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	:	Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	:	Pengembangan Gedung DPM

Februari 2018	:	Menjadi tempat dokter internsip
Maret 2020	:	Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Covid-19 di Jawa Timur (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur)

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT

3.1 VISI

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2 MISI

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3 LANDASAN 7 NILAI BUDI UTAMA

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.4 MOTTO

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Motto :

“Sahabat Menuju Sehat”

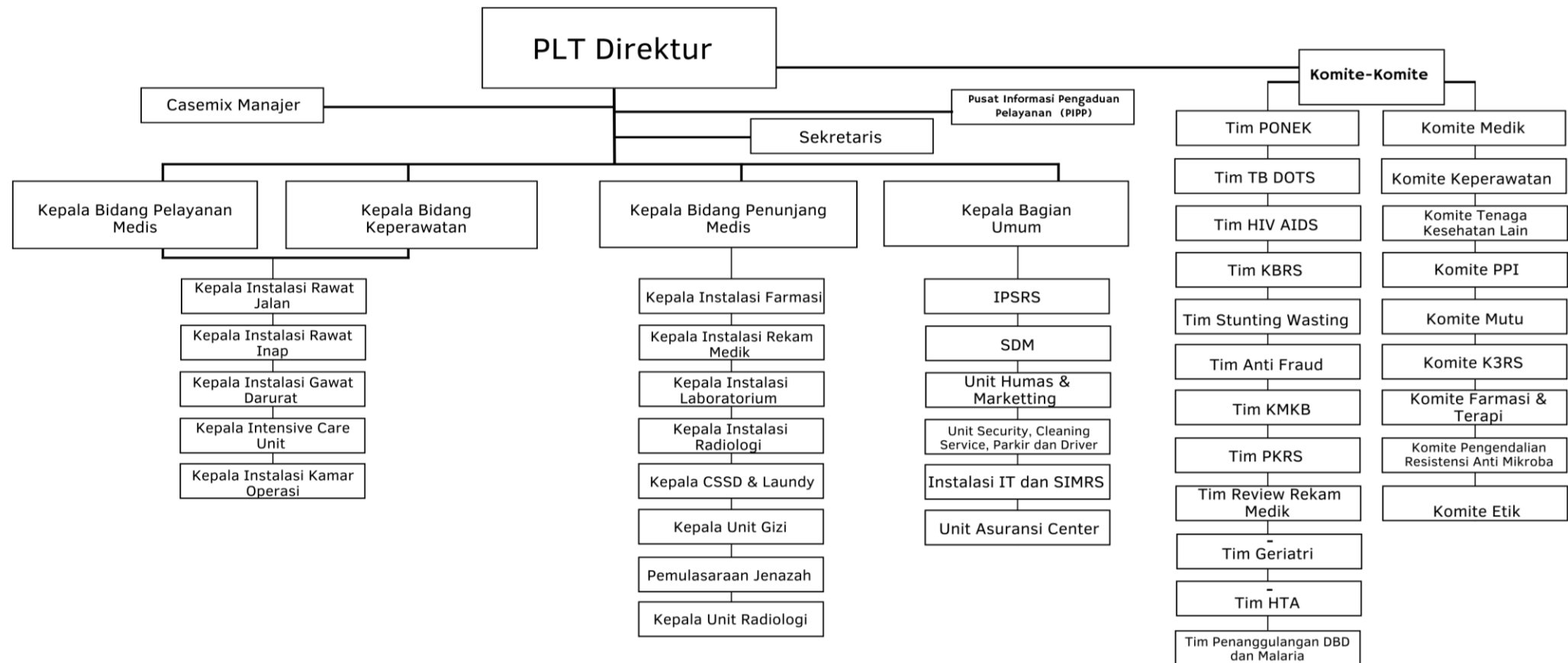
3.5 TUJUAN

Rumah Sakit Prima Husada memiliki tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Prima Husada.

BAB IV

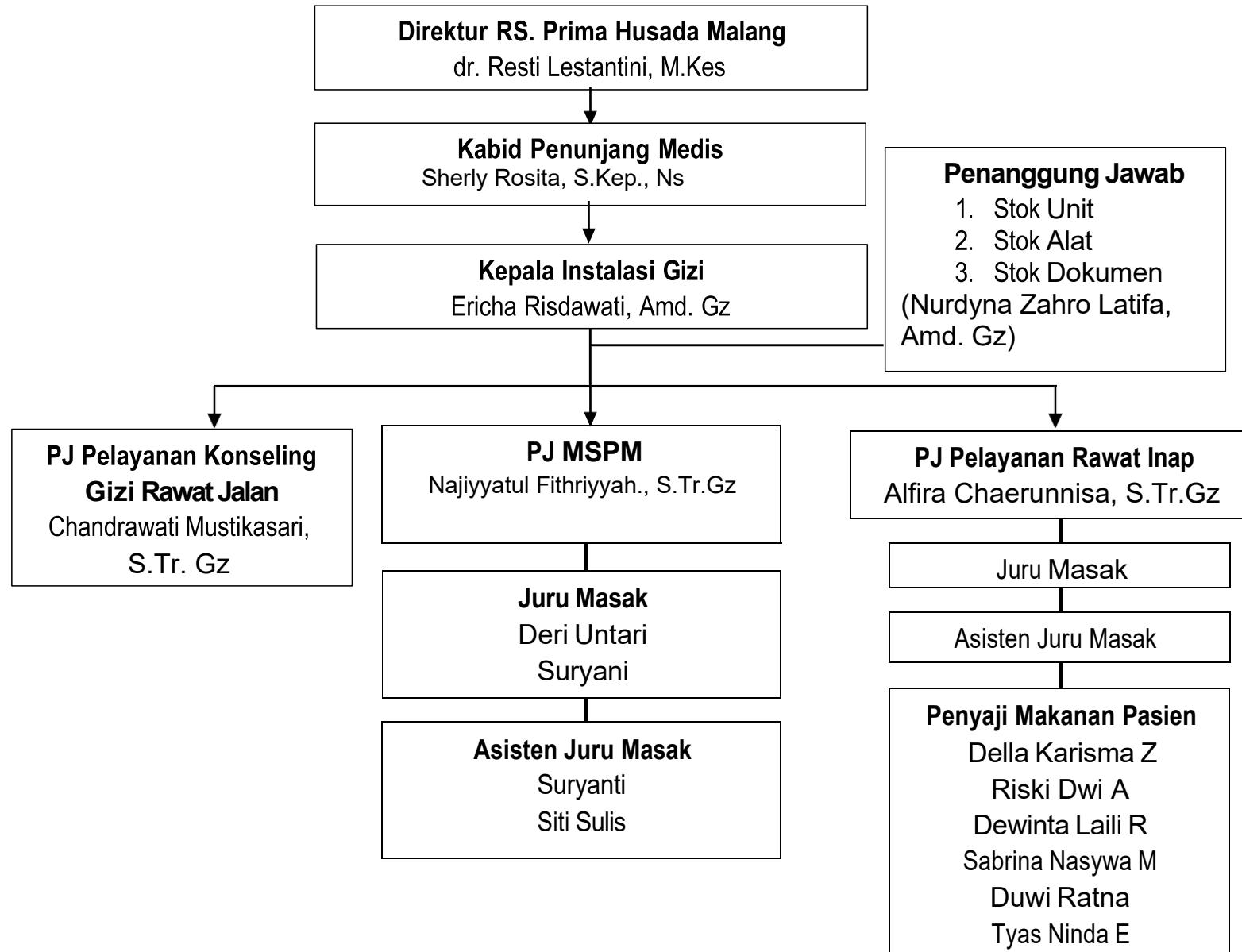
STRUKTUR ORGANISASI RS. PRIMA HUSADA

4.1 BAGAN ORGANISASI



Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada

SOTK INSTALASI GIZI



4.2 Keterangan/ Pengertian

1. Unit Struktural

a. Direktur

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Prima Husada

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit
- 2) Kepala Bidang Keperawatan membantu Direktur bidang keperawatan Rumah Sakit khususnya dalam keperawatan
- 3) Kepala Bidang Penunjang Medis membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit
- 4) Kepala Bidang Umum dan Operasional membantu Direktur dalam bagian :
 - a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - ~~b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.~~
 - c) Umum meliputi : Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tangga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

2. Kepala Instalasi dan Kepala Bagian

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- a. Kepala Instalasi Gawat Darurat
- b. Kepala Instalasi Rawat Jalan
- c. Kepala Instalasi Rawat Inap
- d. Kepala *Intensive Care Unit*
- e. Kepala Instalasi Kamar Operasi
- f. Kepala Instalasi Farmasi
- g. Kepala Instalasi Rekam Medis
- h. Kepala Instalasi Laboratorium
- i. Kepala Instalasi Radiologi
- j. Kepala Instalasi CSSD dan Laundry
- k. Kepala Instalasi Gizi
- l. Kepala Bagian Ketatausahaan dan Humas
- m. Kepala Bagian SDM
- n. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
- o. Kepala Instalasi SIMRS
- p. Kepala Bagian IPSRS
- q. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga
- r. Kepala Bagian Asuransi Center

3. Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia/ Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

-
- a. Komite Medis
 - b. Komite Keperawatan
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain
 - d. Komite PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
 - e. Komite PMKP (Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien)
 - f. Komite Etik
 - g. Komite Farmasi dan Terapi
 - h. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
 - i. Panitia P2K3 (Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit)
 - j. Tim TB DOTS
 - k. Tim PONEK
 - l. Tim HIV/AIDS
 - m. Tim Stunting dan Wasting
 - n. Tim Keluarga dan Berencana Rumah Sakit
 - o. Tim PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit)
 - p. Tim KMKB (Kendali Mutu Kendali Biaya)
 - q. Tim Anti Fraud

BAB V

URAIAN JABATAN

1.1. URAIAN JABATAN

1. Kepala Unit Gizi
 - a. Pendidikan
 - 1) Lulusan DIII/ DIV/ S1 Gizi
 - 2) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Gizi
 - 3) Memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
 - 4) Memiliki Surat Sumpah Ahli Gizi
 - 5) Memiliki Sertifikat Register Dietisien (bila sudah profesi)
 - b. Memiliki Pengetahuan dan keterampilan
Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
 - c. Pengalaman
Pengalaman di bidang gizi minimal 3 Tahun
 - d. Sertifikasi
Sertifikat pelatihan PMKP, PPI, HACCP,BHD, Penanggulangan bencana
2. Penanggung Jawab Pelayanan Konseling Gizi (Rawat Inap & Rawat Jalan)
 - a. Pendidikan
 - 1) Lulusan DIII/ DIV/ S1 Gizi
 - 2) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Gizi
 - 3) Memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
 - 4) Memiliki Surat Sumpah Ahli Gizi
 - b. Pengetahuan dan keterampilan
Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
 - c. Pengalaman
Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun
 - d. Sertifikasi
Sertifikat pelatihan PMKP, PPI, HACCP,BHD, Penanggulangan bencana
3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Makanan (MSPM)
 - a. Pendidikan
 - 1) Lulusan DIII/ DIV/ S1 Gizi
 - 2) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Gizi
 - 3) Memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
 - 4) Memiliki Surat Sumpah Ahli Gizi
 - b. Pengetahuan dan keterampilan
Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
 - c. Pengalaman
Pengalaman di bidang MSPM minimal 1 tahun
 - d. Sertifikasi
Sertifikat pelatihan PMKP, PPI, HACCP,BHD, Penanggulangan bencana
4. Penanggung Jawab Pelayanan Gizi Rawat Inap
 - a. Pendidikan
 - 5) Lulusan DIII/ DIV/ S1 Gizi
 - 6) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Gizi
 - 7) Memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
 - 8) Memiliki Surat Sumpah Ahli Gizi
 - b. Pengetahuan dan keterampilan
Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

- c. Pengalaman
Pengalaman di bidang klinis minimal 1 tahun
 - d. Sertifikasi
Sertifikat pelatihan PMKP, PPI, HACCP, BHD, Penanggulangan bencana
5. Juru Masak
- a. Pendidikan
Lulusan SMA/SMK (Jurusan Tata Boga Lebih diutamakan)
 - b. Pengetahuan dan keterampilan
Keterampilan dalam mengolah berbagai variasi makanan
 - c. Pengalaman
Pengalaman di bidang jasa boga minimal 3 tahun
 - d. Sertifikasi
PMKP, PPI, BHD, Komunikasi Efektif, Penanggulangan Bencana, Higiene sanitasi makanan
6. Asisten Juru Masak
- a. Pendidikan
Lulusan SMA/SMK (Jurusan Tata Boga Lebih diutamakan)
 - b. Pengetahuan dan keterampilan
Keterampilan dalam mengolah berbagai variasi makanan
 - c. Pengalaman
Pengalaman di bidang jasa boga minimal 1 tahun
 - d. Sertifikasi
PMKP, PPI, BHD, Komunikasi Efektif, Penanggulangan Bencana, Higiene sanitasi makanan
7. Penyaji
- a. Pendidikan
Lulusan SMA/SMK (Jurusan Tata Boga/Perhotelan lebih diutamakan)
 - b. Pengetahuan dan keterampilan
Keterampilan dalam memberikan service yang baik, dapat komunikasi efektif dengan baik
 - c. Pengalaman
Pengalaman di bidang jasa boga minimal 3 tahun
 - d. Sertifikasi
PMKP, PPI, BHD, Komunikasi Efektif, Penanggulangan Bencana, Higiene sanitasi makanan

1.2. URAIAN TUGAS

1. Kepala Unit Gizi
- a) Menyusun dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran Instalasi Gizi terkait SDM, Fasilitas, Pengembangan Pelayanan, Mutu, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Kerja Instalasi Gizi disesuaikan dan/atau berdasarkan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku.
 - b) Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Instalasi Gizi dan melaksanakannya.
 - c) Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana.
 - d) Menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya.
 - e) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit.
 - f) Menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit.
 - g) Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan.
 - h) Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggungjawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas.

-
- i) Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap gizi pelaksana.
 - j) Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan.
 - k) Memastikan pelayanan pasien sesuai pedoman pelayanan gizi dan standar prosedur yang berlaku
 - l) Melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit.
 - m) Menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya.
 - n) Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya.
 - o) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin.
 - p) Menjaga proses kontrol mutu terhadap ikatan kerja sama yang ada.
 - q) Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat.
 - r) Bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada.
 - s) Bertanggungjawab atas pelayanan gizi rawat inap, rawat jalan, Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan (MSPM) di rumah sakit.
2. Penanggung Jawab Pelayanan Konseling Gizi (Rawat Inap & Rawat Jalan)
- a) Membantu menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana.
 - b) Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya.
 - c) Melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit.
 - d) Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan.
 - e) Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksana.
 - f) Membantu menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan.
 - g) Melaksanakan pelayanan gizi klinik rawat jalan dan rawat inap sesuai pedoman pelayanan gizi dan standar prosedur operasional yang berlaku.
 - h) Membantu melakukan sosialisasi mengenai peraturan/ tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit.
 - i) Membantu menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya.
 - j) Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya.
 - k) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin.
 - l) Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat.
4. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Makanan (MSPM)
- a) Mengkoordinasi tugas kerja dibagian dapur
 - b) Merencanakan kebutuhan sediaan bahan makanan secara optimal.
 - c) Mengadakan sediaan bahan makanan dan bahan habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Mengawasi pemesanan, pembelian, penerimaan bahan makanan, bahan

habis pakai,dan peralatan

- e) Menerima sediaan bahan makanan sesuai dengan spesifikasi yang berlaku.
- f) Memeriksa persediaan bahan yang mendekati waktu kadaluwarsa
- g) Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahan makanan dan bahan habis pakai.
- h) Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan sediaan bahan untuk penyelenggaraan makanan
- i) Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan

5. Penanggung Jawab Pelayanan Gizi Rawat Inap

- a) Membantu menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana.
- b) Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal-hal terkait di unitnya.
- c) Melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit.
- d) Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan.
- e) Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksana.
- f) Membantu menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas,
- g) dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan
- h) Melaksanakan pelayanan gizi klinik rawat inap sesuai pedoman pelayanan gizi dan standar prosedur operasional yang berlaku.
- i) Membantu melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit dan menjaga agar seluruh sumber daya manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di rumah sakit.
- j) Membantu menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya.
- k) Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya.
- l) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan secara rutin.
- m) Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah dibuat.

6. Juru Masak

- a) Membantu gizi mspm untuk melakukan tugas rutin di instalasi gizi rumah sakit.
- b) Menyiapkan peralatan yang akan dipakai untuk proses pengolahan.
- c) Menyiapkan semua bumbu dan bahan makanan yang diolah
- d) Menghitung jumlah porsi makan yang akan diolah sesuai permintaan
- e) Mengolah semua bahan yang telah disiapkan sesuai menu

8. Asisten Juru Masak

- a) Membantu juru masak dan gizi mspm untuk melakukan tugas rutin di instalasi gizi rumah sakit.
- b) Membantu Menyiapkan peralatan yang akan dipakai untuk proses pengolahan.
- c) Membantu Menyiapkan semua bumbu dan bahan makanan yang diolah
- d) Membantu Menghitung jumlah porsi makan yang akan diolah sesuai permintaan
- e) Membantu Mengolah semua bahan yang telah disiapkan sesuai menu
- f) Membantu membersihkan tempat pengolahan setelah selesai digunakan

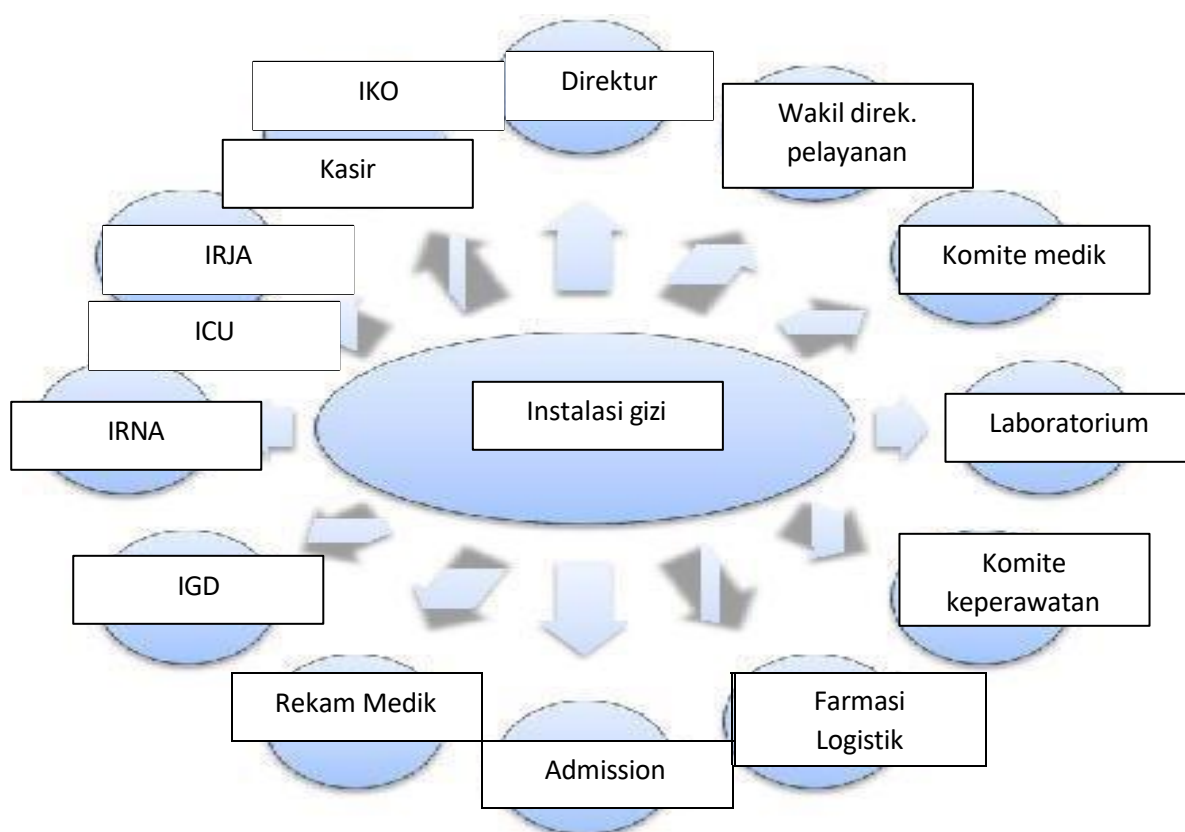
9. Penyaji

- a) Menyiapkan peralatan makan dan minum untuk pasien.
- b) Menyiapkan minuman untuk pasien
- c) Membagi etiket makan pada baki/plato makan pasien sesuai kelas, ruang dan diet

-
- d) Membagi makan pasien sesuai kamar, nama pasien, tanggal lahir pasien dan diet pasien.
 - e) Memberikan informasi terkait hak dan kewajiban pasien terkait makanan
 - f) Melakukan konfirmasi perubahan diet kepada ahli gizi yang bertugas di dapur jika ada operan perubahan diet dari pasien ataupun perawat.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA



Dalam Tata hubungan kerja ini, Instalasi Gizi dengan unit terkait adalah melakukan kerjasama dalam hal memberikan keterangan jumlah karyawan dinas untuk penyediaan makanan bagi karyawan dan jumlah makanan untuk pasien sesuai kebutuhan pasien.

- Tata hubungan Direktur dan Wakil Direktur dengan Instalasi Gizi
 - Direktur dan Wakil Direktur membuat kebijakan-kebijakan untuk Instalasi Gizi
 - Direktur dan Wakil Direktur memberitahukan adanya tamu yang harus dilayani Instalasi Gizi mengenai makanan, minuman, dan snack
- Instalasi Rawat Jalan
 - Instalasi Rawat Jalan bekerja sama dengan Instalasi Gizi untuk pelayanan konsultasi pasien di Instalasi Rawat jalan
- Instalasi Rawat Inap
 - Instalasi Rawat Inap bekerja sama dengan Instalasi Gizi dalam pengadaan makan pasien yang dirawat sesuai diet.
 - Instalasi Rawat Inap bekerja sama dengan Instalasi Gizi dalam pelayanan konsultasi gizi pasien
- Instalasi Farmasi
 - Instalasi farmasi bekerjasama dengan instalasi gizi untuk pelayanan formula komersial untuk pasien yang membutuhkan
- Instalasi Gawat darurat
 - Instalasi Gawat darurat bekerjasama dengan Instalasi Gizi untuk pelayanan pemberian makan pasien one day care

-
- Instalasi laboratorium
Instalasi laboratorium bekerja sama dengan instalasi gizi untuk pelayanan bila ada tamu
 - Instalasi Radiologi.
Instalasi radiologi memberikan informasi dokter tamu/dokter yang harus dilayani penyediaan minum dan snack.
 - Instalasi Rehab Medis
Instalasi rehab medis bekerjasama dengan instalasi gizi untuk pasien rawat jalan yang menjalani terapi dan membutuhkan konsultasi gizi
 - Instalasi kamar operasi
 - Instalasi Kamar Operasi memberikan jumlah karyawan dinas yang akan dilayani pemberian makan.
 - Instalasi kamar Operasi memberikan jumlah dokter yang sedang operasi untuk dilayani pemberian makan
 - Bagian Rekam Medis
 - Bagian rekam medis bekerjasama dengan instalasi gizi bila ada tamu yang perlu dilayani untuk pemberian minum.
 - Bagian rekam medis memberikan informasi identitas pasien yang memerlukan konsultasi gizi
 - Bagian Pemasaran
Bagian pemasaran bekerja sama dalam memasarkan rumah sakit melalui cerkes, pojok sehat, mobil sehat dan lain-lain
 - Bagian Keuangan
 - Bagian keuangan /kasir bekerjasama dalam urusan keuangan Instalasi Gizi.
 - Bagian Keuangan/kasir bekerjasama dalam penyetoran pendapatan instalasi gizi
 - Bagian Sumber daya manusia
 - Instalasi gizi bekerja sama dengan bagian SDM dalam urusan penggajian.
 - Instalasi gizi bekerjasama dengan bagian SDM dalam urusan kepegawaian baik penerimaan pegawai, kenaikan golongan dan lain- lain.
 - Instalasi gizi bekerja sama dengan bagian SDM dalam pelatihan dan seminar.
 - Bagian Sistem Informasi Manajemen
Instalasi Gizi bekerja sama dengan bagian SIM dalam bidang IT.
 - Bagian Pemeliharaan sarana
Instalasi Gizi bekerja sama dengan BPS dalam pembuatan ataupun perbaikan peralatan di Instalasi gizi
 - Bagian Inventori
 - Instalasi Gizi bekerja sama dengan bagian inventori dalam pemesanan dan pengadaan bahan makanan kering, bahan habis pakai.
 - Instalasi gizi bekerja sama dengan bagian inventori dalam pengadaan barang rumah tangga.
 - Instalasi gizi bekerjasama dengan bagian inventori (unit HK) dalam inventaris peralatan, pelayanan tamu rumah sakit
 - Bagian Administrasi
 - Bagian administrasi memberikan informasi tentang surat menyurat.
 - Bagian administrasi memberikan informasi tentang tamu rumah sakit yang memerlukan pelayanan makan.

-
- Bagian administrasi memberikan informasi tentang rapat-rapat didalam rumah sakit yang memerlukan pelayanan konsumsi.

BAB VII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

7.1 Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi Gizi memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

7.1.1 Dari dalam RS. Prima Husada sendiri (*internal resources*)

Menarik calon dari dalam RS Prima Husada sendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada

7.1.2 Dari luar RS. Prima Husada (*external resources*)

Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Kriteria calon karyawan menurut standar Gizi RS Prima Husada :

1. Ahli Gizi

- a. Lulusan D3/ DIV/ S1 Gizi.
- b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
- c. Memiliki IPK minimal 2,75 untuk Perguruan Negeri, IPK minimal 3,00 untuk Perguruan Swasta.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Memiliki pemahaman tentang Pelayanan Gizi RS dengan baik.
- f. Mudah bekerja secara mandiri dan tim.

2. Petugas Pengolahan

- a. Lulusan SMA/SMK Tata boga lebih diutamakan
- b. Paham tentang pengolahan makanan
- c. Paham tentang higiene sanitasi penjamah makanan
- d. Mampu bekerja secara mandiri dan tim

3. Petugas Penyaji

- a. Lulusan SMA/SMK Tata boga lebih diutamakan
- b. Paham tentang pengolahan makanan
- c. Paham tentang higiene sanitasi penjamah makanan
- d. Mampu bekerja secara mandiri dan tim

7.2 Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi Gizi khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga gizi. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan gizi. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Pendidikan

Tenaga dengan pendidikan setingkat SMA diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi.
2. Pelatihan

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Ahli Gizi di Instalasi Gizi dilaksanakan melalui :

Internal Training yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar , PMKP dan BHD.

External Training yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi Gizi seperti pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
3. Evaluasi dan Pemutakhiran Staf

a. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan

b. Dihadiri oleh direktur, kepala bidang, kepala instalasi/Ruang, SDM

c. Setiap ada staf yang melakukan pengunduan diri

d. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan wal pola ketenagaan

7.3 Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf

Tabel 2. Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil

No.	Nama Jabatan	JUMLAH SDM				KUALIFIKASI					
		Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	Perencanaan	PENDIDIKAN			SERTIFIKASI		
						Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan
1.	Kepala Instalasi Gizi	1	1	-	-	S1/ D3/ D4 Gizi	D3 Gizi	-	Ijazah S1/ D3/ D4 Gizi	Ijazah D3 Gizi	-
2.	Ahli Gizi	5	5	1	1 ahli gizi resign pada bulan Oktober 2026 karena SIK Gz non aktif	S1 Gizi D3 Gizi D4 Gizi	S1 Gizi D3 Gizi D4 Gizi	1	Ijazah S1 Gizi Ijazah D3 Gizi Ijazah D4 Gizi	Ijazah S1 Gizi Ijazah D3 Gizi Ijazah D4 Gizi	-
3.	Juru Masak	2	2	-	-	SMK	SMK	-	Ijazah SMK	Ijazah SMK	-
4.	Asisten juru masak	2	2	-	-	SLTP / SMK	SLTP / SMK	-	Ijazah SLTP/ SMK	Ijazah SLTP/ SMK	-
5.	Pemorsian	3	3	-	-	SMA/ K	SMA/ K	-	Ijazah SMA/K	Ijazah SMA/K	-
	Penyaji	3	3	-	-	SLTP / SMK	SLTP / SMK	-	Ijazah SLTP/ SMK	Ijazah SLTP/ SMK	-

Pada Rumah Sakit yang belum memiliki tenaga gizi sesuai klasifikasi sebagai mana tersebut, dapat memanfaatkan tenaga gizi yang dimiliki dengan secara bertahap melakukan peningkatan kemampuan dan pembinaan tenaga tersebut agar memenuhi kualifikasi termaksud. Dan jumlah tenaga gizi yang ada di Rumah Sakit Prima Husada yang ada dan dapat dimanfaatkan sejumlah 5 orang dengan 1 orang ahli gizi yang merangkap tugas pelaksana dan Ka. Instalasi.

Tabel 2. Perhitungan Pola Ketenagaan Gizi Berdasarkan Beban Kerja (Permendagri No.12 tahun 2008)

No.	Tugas Pokok	Uraian Tugas	Rerata Volume Kerja Perhari	Waktu Yang Dibutuhkan	
				Satuan	Jumlah
1.	QC (Quality Control)	Melakukan control terhadap makanan dari segi rasa, tampilan dan kebersihan	70	5 menit	350
2.	Mengisi status pasien	Mengerjakan asuhan gizi dari pengkajian awal hingga rencana intervensi dan monitoring evaluasinya	40	20 menit	800
3	Visite pasien	Mengedukasi pasien terkait diet sesuai dengan kasus nya	40	15 menit	600
4	KIE Rawat Inap	Mengedukasi pasien baru atau mengedukasi pasien yang akan pulang di rawat inap	40	10 menit	400
5	KIE Rawat Jalan	Mengerjakan asuhan gizi rawat jalan	10	10 menit	100
6		Mengedukasi diet pasien sesuai dengan diagnose pasien dan dilakukan di rawat jalan	10	20 menit	200
Jumlah waktu					2450
Jam kerja					420
Total kebutuhan Karyawan					5,8

Tabel 3. Perhitungan Pola Ketenagaan petugas dapur Berdasarkan Beban Kerja (Permendagri No.12 tahun 2008)

No	Tugas Pokok	Uraian tugas	Volume kerja per hari	waktu yang dibutuhkan (menit)	Jumlah
1	Pemesanan bahan makanan	membuat SP	1	30	30
		Input SP	1	30	30
		Konfirmasi Pengeluaran ke PT	1	15	15
2	Penerimaan	Penerimaan bahan makanan dan melakukan penyortiran bahan makanan	1	45	45
3	Penyimpanan Bahan Makanan	Menyimpan bahan makanan sesuai jenis bahan basah atau bahan kering kemudian ditata sesuai sistem FIFO (First In First Out)	1	120	120
		Membersihkan ruang penyimpanan bahan makanan	1	60	60
		Mengisi kartu stok	1	25	25
4	Persiapan Bahan Makanan	Membersihkan bahan makanan dari bagian yang tidak dapat dikonsumsi	1	120	120
		Memotong bahan makanan sesuai bentuk yang dibutuhkan	1	120	120
		Menyimpan bahan makanan sesuai jenis bahan makanan, disimpan dalam box atau plastik, lalu diberi label tanggal penerimaan	1	45	45
5	Pengolahan Makanan	Mencuci bahan makanan	12	15	180
		Memasak sumber KH	3	60	180
		Memasak sayuran	3	60	180
		Memasak lauk pauk	6	60	360
		Memasak Snack pasien dan dokter, dessert pasien VIP/VVIP	1	90	90
		Membuat diet cair khusus	3	60	180
		Membuat menu penunggu, tim IKO, dokter, Klinik Mutiara Sehat	3	90	270
		Membuat makanan untuk event pengajian, senam lansia, senam hamil, snack rapat (conditional)	1	90	90
		Mencuci peralatan masak yang sudah digunakan	3	30	90
		Membersihkan kompor dan area dapur	3	30	90
6	Pemorsian Makanan	Memorsi makanan pasien	3	120	360
		Memorsi snack dokter	2	20	40
		Memorsi menu penunggu, tim IKO, dokter, Klinik Mutiara Sehat	3	30	90
		Memorsi makanan untuk event pengajian, senam lansia, senam hamil, snack rapat (conditional)	3	60	180
		Mencuci peralatan yang telah digunakan untuk memorsi	3	15	45
		Menggunting sedotan, melipat tissue dan membungkus sendok untuk pasien	3	60	180
		Memotong buah untuk pasien	2	30	60
		Menyiapkan minuman pasien (membuat teh dan mengambil air putih), menuang, menutup gelas, dan diatata diatas troli	3	30	90
7	Distribusi Makanan	Membersihkan troli makanan sebelum dipakai	3	15	45
		Crosscheck jumlah pasien pada tiap ruangan dan adanya perubahan diet dari DPJP	3	10	30
		Membagikan makanan pasien	3	60	180
		Membagikan Snack pasien	3	30	90
		Membagikan Snack dokter	2	30	60
		Membersihkan troli setelah digunakan	3	15	45
		8	Lain – lain	update pasien dan perubahan diet kepada Ahli Gizi NS	3
update jumlah pasien ke perawat ruangan	3			15	45
Mengisi link sendok keluar-masuk	3			5	15
Mengisi link suhu ruangan	3			5	15
Menyiapkan jumat berkah (conditional) (PHM, RSDH, MS, MASJID)	1			120	120
Menghitung peralatan makan pasien	3			20	60
Membersihkan Freezer	1			60	60
Membersihkan Ruang Dapur setelah selesai kegiatan	3			30	90
Membuat laporan belanja bulanan	1			15	15
Merekap jumlah makanan keluar ke MS	2			10	20
Menyiapkan garnish (mencuci parshley dan selada, memotong tomat, timun)	3			20	60
Jumlah Waktu					4360
Jam Kerja (Menit)					420
Total Kebutuhan Karyawan					10,38095

Keterangan :

- WPT = Waktu Penyelesaian Tugas
- WKE = Waktu Kerja Efektif

$$\frac{\sum WPT}{\sum WKE} \times 1 \text{ Orang} = 2450 : 420 \times 1 \text{ orang} = 5,8$$

$$\frac{\sum WPT}{\sum WKE} \times 1 \text{ Orang} = 4360 : 420 \times 1 \text{ orang} = 10 \text{ orang}$$

Perhitungan pola ketenagaan instalasi gizi menggunakan pola ABK (Permendagri No.12 tahun 2008) didapatkan jumlah ahli gizi sebanyak 6 orang, dan petugas dapur sebanyak 10 orang, apabila ada penambahan gedung rawat inap atau jumlah tempat tidur, maka akan dilakukan penambahan ahli gizi dan petugas dapur secara bertahap dan akan dievaluasi kinerja pada saat pelayanan berlangsung agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Tabel 4. Pengaturan Jaga di Instalasi Gizi Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1.	Kepala Instalasi Gizi	1 Shift	08.00 – 16.00	1 Orang
2.	Ahli Gizi TRD	4 Shift	Pagi : 06.30–14.30 QC : 05.30 – 13.30 Middle : 11.00 – 19.00 NS QC : 08.00 – 16.00	4 Orang
4.	Juru Masak	3 Shift	Pagi: 03.00 – 11.00 Middle: 06.00 -14.00 Siang: 09.00 – 17.00	2 Orang
5.	Asisten juru masak	3 Shift	Pagi: 03.00 – 11.00 Middle: 06.00 -14.00 Siang: 09.00 – 17.00	2 Orang
6.	Pemorsian	2 Shift	Pagi: 04.00 – 12.00 Siang:09.00 – 17.00	6 Orang
	Penyaji	2 Shift	Pagi: 04.00 – 12.00 Siang:09.00 – 17.00	

Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf
 Dalam upaya mempersiapkan tenaga gizi yang handal perlu adanya perencanaan SDM. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Tabel 5. Pola Ketenagaan dan Kualifikasi SDM :

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi		Kebutuhan
		Pendidikan	Sertifikasi/Pelatihan	
1.	Ka Instalasi	Dokter Gizi	HACCP Nutrition Care Process	-
2.	Ka Ruang Gizi	D3/D4/S1 Gizi	HACCP Nutrition Care Process Mutu dan kes. Px PPI	-
3.	Gizi Pelaksana	D3 Gizi	HACCP Nutrition Care Process Mutu dan kes. Px PPI	-
4.	Gizi Pelaksana	DIV/S1 Gizi	HACCP Nutrition Care Process Mutu dan kes. Px PPI	-
5.	Bagian pengolahan	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	-
6.	Bagian pengolahan	SMP	Mutu dan kes. Px PP	-
7.	Bagian Pemorsian	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	-
8.	Bagian Penyaji	SMA/K	Mutu dan kes. Px PP	

4. Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi. Sebagai contoh, seorang perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke rawat jalan lain.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
 - 1. Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Perinatologi, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihan Instrumen, ditempatkan di Unit Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar di tempatkan di *Unit Care Unit* (ICU)
 - 2. Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjaga stabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai

-
- b. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama;
Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit
 - c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf.

Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Unit Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai Surat Tanda Register (STR), SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala unit kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
- b. Seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- c. Bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh: penugasan penuh waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara)

PROGRAM ORIENTASI

9.1 Orientasi Umum Rumah Sakit

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional di RS Prima Husada, maka dilakukan kegiatan orientasi/ pengenalan lingkungan kerja (*on job training*) yang dilakukan pada baru.

Kegiatan orientasi memberikan pengarahan dan bimbingan serta mempersiapkan petugas gizi agar dapat bekerja cepat dan tepat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Tabel 7. Kegiatan Orientasi Umum

Hari ke	Materi	Waktu	Metoda	Penanggung Jawab
Hari ke I	a. Tujuan orientasi, sejarah, visi, misi, motto RSPH, struktur organisasi RSPH b. Peraturan kepegawaian/KKB c. Service Excellent d. Fasilitas , sarana, produk-produk RSPH e. Etika dan Hukum f. Pegawai diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : 1. Visi, misi, nilai, struktur organisasi 2. Perjanjian kerja 3. Etika bekerja 4. Kesejahteraan spiritual 5. <i>Service excellence</i> 6. <i>Handling complaints</i> 7. Produk produk rumah sakit 8. <i>Basic life support</i> 9. Penanggulan bencana kebakaran 10. <i>Patient safety</i> 11. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah	SDM

9.2 Orientasi Unit

Tabel 8. Kegiatan Orientasi Unit:

Hari Ke	Materi	Waktu	Metoda	Penanggung Jawab
Hari ke II	a. Mempelajari Pedoman Pelayanan Gizi b. Mempelajari Pedoman Pengorganisasian Gizi c. Mempelajari SPO Instalasi Gizi d. Penyampaian uraian tugas gizi e. Sosialisasi SPO gizi f. Melakukan pemesanan makanan pasien rawat Inap	7 jam	Membaca Ceramah Diskusi	Karu Gizi
Hari ke III	a. Pelaksanaan Asuhan Gizi b. Melaksanakan Konsultasi Gizi rawat inap c. Melaksanakan d. Konsultasi Gizi rawat jalan	1 shift	Praktek	Karu Gizi
Hari ke IV	a. Mengikuti kerja yang sebenarnya dengan pendampingan.	1 shift	Praktek	Karu Gizi
Har i ke V	a. Mengikuti kerja yang sebenarnya selama 2 minggu dengan di dampingi kepala ruang	1 shift	Praktek	Karu Gizi

BAB IX PERTEMUAN / RAPAT

10.1 Pengertian

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu

10.2 Tujuan

1. Dapat menggali segala permasalahan terkait dengan pelayanan gizi yang diberikan
2. Dapat mencari jalan keluar atau pemecahan masalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan

10.3 Kegiatan Rapat

Rapat dilakukan / diadakan oleh instalasi gizi yang dipimpin oleh kepala instalasi dan diikuti seluruh staf yang berada dibawah unit kerjanya

10.4 Jenis Rapat Instalasi Gizi terdiri dari :

A. Rapat Rutin

Rapat Internal Instalasi Gizi setiap 1 bulan sekali

Waktu : Setiap Jum'at Minggu ke 2

Jam : 09.00 – selesai

Tempat : Ruang Gizi

Peserta : Kepala Instalasi atau Kepala Ruang, dan Pelaksana

Materi :

- a. Evaluasi Kinerja Mutu
- b. Evaluasi SDM dan Fasilitas Gizi
- c. Permasalahan yang ada serta pemecahannya
- d. Evaluasi dan Rekomendasi

B. Rapat Insidentil

Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu apabila ada masalah atau hal-hal yang perlu dibahas segera

BAB X PELAPORAN

11.1 Pengertian

Pelaporan merupakan sistem atau metode yang dilakukan untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada terkait dengan pemberian asuhan gizi di instalasi gizi

11.2 Jenis Laporan

Laporan dibuat oleh tiap-tiap kepala ruang gizi. Adapun jenis laporan yang dilakukan terdiri dari :

1. Laporan Harian

Laporan harian berupa pencatatan jumlah makanan diet pasien rawat inap, pencatatan data/register pasien rawat inap dan rawat jalan yang mendapatkan asuhan gizi berupa konsultasi gizi

2. Laporan Bulanan

Laporan yang dibuat oleh kepala ruang dalam bentuk tertulis setiap bulannya dan diserahkan kepada Sekretariat tiap tanggal 3. Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan SDM Gizi yang meliputi :
 - 1) Kuantitas SDM
 - 2) Kualitas SDM
- b. Laporan fasilitas dan sarana Gizi yang meliputi :
 - 1) Kelengkapan alat dan fasilitas
 - 2) Kondisi alat dan fasilitas
- c. Laporan Produktivitas Gizi yang meliputi :
 - 1) Jumlah pemberian diet pasien
 - 2) Jumlah KIE rawat inap
 - 3) Jumlah KIE rawat jalan
- d. Laporan Kinerja Mutu
 - 1) Indikator mutu pelayanan
 - 2) Indikator keselamatan pasien

11.3 Laporan Tahunan

Laporan yang dibuat oleh Karu dalam bentuk tertulis setiap tahun dan diserahkan kepada kepala Instalasi Gizi tiap tanggal 5. Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah :

- a. Laporan SDM gizi dan evaluasi dalam satu tahun
- b. Laporan fasilitas dan sarana gizi dan evaluasi dalam satu tahun
- c. Laporan produktivitas gizi dan evaluasi dalam satu tahun
- d. Laporan kinerja mutu pelayanan gizi dan evaluasi dalam satu tahun

BAB XI

PENUTUP

Demikianlah Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi disusun yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi dengan baik dan benar sesuai ketentuan standar pelayanan kesehatan bidang gizi sehingga pelayanan kesehatan prima dapat terwujud.

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Gizi ini disusun dengan memperhitungkan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya senantiasa untuk dilengkapi sesuai kebutuhan pelayanan.

Semoga pedoman pengorganisasian Instalasi Gizi ini dapat dipergunakan oleh seluruh Instalasi Gizi dan bermanfaat bagi peningkatan mutu layanan di pelayanan Gizi Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 6 Juni 2026
Direktur Rumah RS Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes